

二十四节气养生歌赏析(廿三)

——大雪养生

王志华 李彦知 杨建宇*

(中国中医药现代远程教育杂志社, 北京 100021)

关键词: 二十四节气; 大雪; 养生歌诀

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2012.23.063

文章编号:1672-2779(2012)-23-0091-02

[歌诀] 大雪进补春打虎,
户外防寒睡眠足,
颈肩腰腿关节部,
防寒保暖丹田腹,
蛋白脂肪糖维素,
鸡狗羊肉脾肾补。

1 原文解释

大雪时天气寒冷,在养生方面宜注意防寒保暖,尤其应避免颈肩、胸腹、腰腿等部位受寒。饮食上宜“进补”,可多吃富含蛋白质、糖、脂肪和维生素的食物,以补充因天寒而消耗的能量;可常食羊肉、狗肉、鸡肉、虾仁等食物以补脾肾阳气。

2 节气特点

大雪节气时值每年公历的12月7~8日,视太阳到达黄经255°时开始。历书载:“斗指甲,斯时积阴为雪,至此栗烈而大,过于小雪,故名大雪也。”《月令七十二候集解》曰:“十一月节,大者盛也,至此而雪盛也”。可见,大雪节气和小雪、雨水、谷雨等节气一样,都是直接反映降水的节气。我国古代将大雪分为三候:“一候鹖鴒不鸣;二候虎始交;三候荔挺出。”意思是说小雪时因天气寒冷,寒号鸟也不再鸣叫了;由于此时是阴气最盛时期,正所谓盛极而衰,阳气已有所萌动,所以老虎开始有求偶行为;“荔挺”(兰草的一种)也因感到阳气的萌动而抽出新芽。大雪节气时,除华南和云南南部无冬区外,我国大部分地区已进入寒冬,东北和西北地区平均气温已降至零下10℃,甚至更低;华北地区和黄河流域气温也达到0℃以下。在强冷空气前沿冷暖空气交锋的地区会降大雪,甚至暴雪。

3 养生要点

3.1 起居养生

3.1.1 早睡晚起补睡眠 大雪时节养生应遵循《黄帝内经》“早卧晚起,必待日光”的原则,保证充足睡眠。早睡可养人体阳气,保持身体的温热;晚起可养阴气,待

日出而起,可躲避严寒,用冬眠状态养精蓄锐,使人体达到阴平阳秘,为来年春天气机勃发做好准备。

3.1.2 胸腹腰腿重保暖 大雪节气天气寒冷,风寒之邪容易损伤人体,故应做好防寒保暖工作,尤其应保护好胸腹和关节部位。因为胸部受寒之后,易折伤体内阳气,从而引发心脏病;而腹部受寒则易引起胃肠疾患。因此,在大雪时节要重视胸腹部的保暖。除了胸腹之外,颈肩和腰腿部也是易受寒邪侵袭的部位。颈肩部受了风寒后,肌肉容易痉挛、疼痛,甚至还会牵扯到背部;腰为肾之府,肾为人体先天之本,腰部受寒冷刺激,易使局部血管收缩,血流减缓,引起腰部疼痛;腿部受寒则腿部肌肉容易发生收缩、痉挛,甚至引发膝关节炎。因此大雪时节应格外重视以上部位的保暖,除了要穿些防寒的衣服外,还应扎上围巾以保护颈肩,必要时应戴上护膝以保护腿部。

3.2 饮食养生 大雪时节饮食宜“进补”。我国民间素有“冬季进补,开春打虎”的俗语,说明了冬季进补的重要意义。因为冬季是匿藏精气的时节,由于气候寒冷,人体的生理功能处于低谷,趋于封藏沉静状态,人体的阳气内藏,阴精固守,是机体能量的蓄积阶段,也是人体对能量营养需求较高的阶段。同时,大雪时节人体的消化吸收功能相对较强,因此,适当进补不仅能提高机体的免疫能力,还能使营养物质转化的能量最大限度地贮存于体内,有助于体内阳气的升发,为来年开春乃至全年的健康打下良好的物质基础。大雪节气时进补应顺应自然,注意养阳,以滋补为主。补法主要有两种:一是食补,二是药补。但俗话说得好,“药补不如食补”。因此,食补是冬季进补的主要方法。由于冬季寒冷,人体为了保存一定的热量,就必须增加体内碳水化合物、脂肪和蛋白质的分解,以便产生更多的能量满足机体的需要。因此,冬天应多吃富含蛋白质、糖、脂肪和维生素的食物,以补充因天寒而消耗的能量。也宜常食羊肉、狗肉、鸡肉、虾仁、桂圆、大枣等食物,这些食物中富含蛋白质和脂肪,产热量多,对于素体虚寒、阳气不足者尤宜。

一些身体虚弱的人在食补的同时,也可以用补肾延

* 基金项目:世中联(北京)远程教育科技发展中心十二五攻关项目
(NO SZ125008)

* 通讯作者

年的药物进补,宜选择的中药有:紫河车、蛤蚧、杜仲、人参、黄芪、阿胶、冬虫夏草、枸杞子等,可和肉类一起做成药膳食用,也可将以上中药浸泡成药酒,在寒冷的大雪时节适度饮用,可滋补肾阳,温通血脉,促进血液运行,帮助人体抵御寒气。

3.3 运动养生 大雪节气可选择动作幅度较小的有氧运动,如快走、慢跑、跳绳、爬楼梯、散步、太极拳等,在运动前一定要做好热身活动。因为大雪时节天气寒冷,人体各器官系统保护性收缩,肌肉、肌腱和韧带的弹力和伸展性降低,肌肉的黏滞性增强,关节活动范围减小,身体容易发僵,不易舒展。如果不做热身活动就锻炼,往往会造成肌肉拉伤、关节扭伤。因此大雪节气进行健身锻炼,尤其是在室外锻炼时,首先应做好充分的热身活动。

除了以上运动方式外,本时节也可做“大雪十一月

节行动”以健身祛病,具体做法是:每天晚上自然站立,两脚左右分开约与肩同宽,膝关节稍屈,两臂伸直外展平举,手心朝上,指尖朝上,抬腿原地踏步走10分钟,然后上下齿相叩,即叩齿36次,漱津几次,待津液满口分3次咽下,意想把津液送至丹田。如此漱津3次,一呼一吸为一息,如此36息而止。此运动可改善关节肿痛、膝风湿毒气、口热舌干、咽肿、上气、烦心、心痛、阴下湿等。

3.4 精神养生 大雪时节人的情绪易处于低落状态,故应注重精神调养。此时的精神调养应着眼于“藏”,即要保持精神安静,防止季节性情感失调症。改变低落情绪的较好方法是多晒太阳,同时加强体育锻炼,尽量避免紧张、易怒、抑郁等情绪的发生。

(本文校对:张文娟 收稿日期:2012-10-20)

基于络病理论治疗糖尿病胃轻瘫浅述

陈 曦 朴春丽 高 蕾

(长春中医药大学附属医院, 长春 130021)

摘 要: 糖尿病胃轻瘫是糖尿病常见的慢性并发症,不仅影响患者的生活质量,而且常因导致不可预测的血糖波动而促使病情恶化。西医治疗本病主要是控制血糖,配合胃动力药,治疗效果不佳。根据久病入络理论,在中医辨证分型治疗的基础上,加用化瘀通络之品,临床上往往可获佳效。

关键词: 络病学说;糖尿病胃轻瘫;辨证诊治

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2012.23.064

文章编号:1672-2779(2012)-23-0092-02

糖尿病胃轻瘫是糖尿病一种常见的慢性并发症,是由于糖尿病合并胃肠自主神经病变引起的胃肠动力功能减弱、胃排空延缓,以上腹胀满、早饱、厌食、恶心呕吐、嗝气、吞酸等为主要表现的一组临床症候群。本病易加重对血糖控制的难度,使血糖忽高忽低。而血糖控制不理想,又加重胃轻瘫病情,如此形成恶性循环。对本病治疗主要是强调血糖控制配合胃动力药,但治疗效果较差。中医文献中虽无与糖尿病胃轻瘫明确相对应的病名,但对其病因病机、辨证治疗已有较系统的认识。经准确辨证,依此立法组方用药,临床上往往可以收到较好疗效。

1 络病学说简介

络病学说是中医理论体系的重要组成部分,对其认识萌芽于《黄帝内经》,《灵枢·脉度》云:“经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。”首次提出络脉概念,并初步论述了络脉的分布及生理病理。络病学说发展于东汉张仲景,《伤寒杂病论》在疾病治疗上,首创化瘀通络法及虫类搜剔通络法。至清代叶天士在《临证指南医案》中提出了“久病入络”、“久痛入络”的病机演变规律,并提出“络以辛为泄”、“大凡络虚,通补最宜”,创辛味通络之法及辛甘通补、滋润通补之法,至此络病学说形成较完整的理论体系。目前认为,络脉涵盖并远远超出了微血管和微循环的内容。络病是以络脉阻滞为特征的

一类疾病,各种病症发展到一定阶段均存在络脉病变,络病多属缠绵难愈的慢性病。

2 糖尿病胃轻瘫病因病机及辨证论治

糖尿病相当于中医学的消渴。消渴病的基本病机为阴津亏耗,燥热内盛,阴虚为本,燥热为标。若疾病迁延日久燥热伤阴耗气可致气阴两虚,气虚则血行无力、阴血不足因虚致瘀,终致瘀血内生,久病入络,导致络病,因此致使糖尿病慢性并发症的出现。

笔者认为糖尿病胃轻瘫病位在胃,其发病与肝脾关系密切。《素问·厥论》曰:“脾主为胃行其津液者也”。《临证指南医案》云:“脾宜升则健,胃宜降则和”。脾主升,胃主降,二者相反相成,胃受纳腐熟水谷功能之正常,有赖于脾运化功能相配合。《素问·宝命全形论》提出:“土得木而达”,肝主疏泄,能调畅全身气机,肝之疏泄功能正常,则脾胃运化功能健旺。消渴日久肝失疏泄,脾失健运;胃阴不足,失其润降;久病入络,血行不畅,阻于胃络,则胃失通降而发为本病。临床上将本病辨证分为以下4型:①肝郁脾虚挟瘀型:症见性情急躁,胸胁胀满,疼痛拒按,纳少倦怠,食后饱胀,恶心欲吐,大便干稀不调,舌淡、可见瘀斑,苔白,脉弦细涩。治以疏肝健脾,化瘀通络。方用逍遥散合丹参饮加减。②脾胃气虚挟湿瘀型:症见脘腹痞闷,纳呆,时时欲呕,面色少华,肢倦身重,口淡不渴,大便溏薄,小